

신장암 진단 첫 30일

감시 · 부분절제 · 면역치료 결정

처음 진단받은 환자와 보호자를 위한 핵심 정리 · 질문 · 행동 가이드

ApuDa 「암 진단 첫 30일」 시리즈 06

MINI 무료 배포판 · Instagram 구독자용 · 2026년 10월 개정 2판

작은 신장 종양은 ‘모두 떼어내야 하는 암’과 같은 말이 아닙니다.

이 책을 펴기 전에

- 이 책은 **일반적인 환자교육 자료**입니다. 나의 병기, 치료 순서, 약 선택, 예후는 담당 의료진과 함께 결정합니다.
- 의학정보 확인일: **2026.10.04** · 참고 지침: NCCN Clinical Practice Guidelines in Oncology — Kidney Cancer, Version 1.2027 외 국내 자료 (본문 끝 「근거와 한계」 참고)
- 약의 국내 허가·건강보험 급여 기준과 제도(산정특례·지원사업)는 자주 바뀝니다. 실제 적용 전 병원 원무과·국민건강보험공단(1577-1000)에서 다시 확인하세요.
- 이 책은 NCCN이 검토하거나 승인한 자료가 아니며, ApuDa가 독자적으로 쓴 환자교육 저작물입니다.

이 MINI판에 대하여

이 MINI판은 진단 후 첫 30일 동안 **안전하게 판단하는 데 꼭 필요한 내용만** 담았습니다. 응급 신호, 진단 직후 할 일, 병리·병기의 핵심, 치료 흐름, 진료실 질문, 한 장 요약은 완전판과 같습니다. 30일 일자별 실행 로드맵, 치료별 준비·회복 가이드, 한국 제도·보험 서류 안내, 마음 돌보기와 보호자 가이드, 워크북은 완전판에 있습니다.

PART 1. 진단 첫 주 — 정확히 알기

1장. 먼저 구분하세요: 작은 신종양, 국소 신장암, 전이성

30초 요약

- 신장 종양은 건강검진·다른 검사 중 **우연히** 발견되는 경우가 많습니다.
- **4cm 이하 작은 신종양** 중 일부는 수술 후 **양성**으로 나옵니다. 그래서 크기·성장 속도·조직검사를 함께 보고 **감시·소작·부분절제** 중에서 고릅니다.
- 가장 흔한 조직형은 **투명세포 신세포암**이며, 조직형에 따라 전신치료가 달라집니다.
- 콩팥 하나로도 대부분 정상 생활이 가능합니다. 다만 **신장 기능 보존**이 치료 선택의 중요한 기준입니다.

상황	흔한 선택지
작은 신종양(약 4cm 이하)	적극적 감시 / 국소소작 / 부분신절제
국소 신장암(4cm 초과, 신장에 국한)	부분 또는 근치적 신절제
국소진행(정맥 침범 등)	근치적 신절제 ± 혈전 제거, 고위험이면 보조 면역치료
전이성	전신치료(면역 병용 등) ± 신절제·전이 절제·방사선

낭성 병변(Bosniak 분류) 한눈에

등급	의미(일반적)
I-II	대개 양성 낭종
III	추적 관찰

오늘 물어볼 질문

1. 제 종양의 크기와 위치는? 고형인가요, 낭성인가요?
2. 감시·소작·부분절제·전절제 중 무엇이 가능한가요?
3. 조직검사가 필요한가요?

2장. 기다리지 않는 신호

⚠ 응급 상자

- **소변에 핏덩이가 나오거나 소변이 막힘**, 심한 옆구리 통증
- 수술 후 **38°C 이상 발열**, 상처 고름, 배가 부풀고 아픔, 소변량 급감
- 갑작스러운 **홍통·숨참**, 한쪽 다리 부종(혈전)
- 면역치료 중: **심한 피로·어지럼·저혈압**(부신 위기), **심한 갈증·잦은 소변**(고혈당), **홍통·두근거림**(심근염), 심한 설사·혈변, 숨참
- **등 통증 + 다리 힘 빠짐·대소변 장애**(척수 압박)
- 먹는 표적치료 중 **혈압이 평소보다 크게 오르면서 심한 두통·흐린 시야·홍통**(고혈압 위기 — 기준 수치는 담당의 확인)
- 스스로를 해치고 싶은 생각 → ☎ 109, 119

본문 목록:

1. 혈뇨·소변 막힘은 출혈이나 핏덩이에 의한 막힘일 수 있습니다.
2. 수술 후 발열·복부 팽만·소변 감소는 감염·출혈·신장 기능 저하 신호입니다.
3. 암은 혈전 위험을 높입니다.
4. 면역치료 부작용 중 부신 위기·당뇨병·심근염은 드물지만 빠른 치료가 필요합니다.

5. 척추 전이에 의한 신경 압박은 시간이 중요합니다.
6. 혈관신생억제제는 혈압을 올릴 수 있어, 두통·흐린 시야를 동반한 급격한 혈압 상승은 바로 연락합니다.

밤·주말 연락처: _____ (병원 암 상담 전화·응급실)

3장. 진단 뒤 72시간

30초 요약: 오늘은 ① 영상 판독지 받기 ② 비뇨의학과(비뇨기종양) 예약 ③ 신장 기능(크레아티닌)·당뇨·고혈압 정리.

오늘 할 일 (3개)

- ☐ CT·MRI 판독지와 영상 CD
- ☐ 비뇨의학과(비뇨기종양 전문) 예약
- ☐ 신장 기능 수치, 당뇨·고혈압 여부, 복용 약 정리

이번 주 할 일

- ☐ 흉부 CT 등 병기 검사(PET/CT는 모든 환자에게 필요하지 않음)
- ☐ 신장 기능이 낮거나 조영제 알레르기가 있으면 검사 전 알리기
- ☐ 젊은 나이(대략 46세 이하)·양측·여러 개·가족력이면 **유전상담** 문의
- ☐ 산정특례: 대개 **병리 확진 후** 등록. 조직검사 없이 감시·수술 대기 중이면 등록 시점을 원무과에 확인

오늘 물어볼 질문

1. 영상에서 암일 가능성은 어느 정도로 보이나요?
2. 제 신장 기능은 수술 후 어떻게 될까요?
3. 유전상담이 필요한가요?

4장. 병리와 병기

30초 요약: 조직형(투명세포·유두상·협색소 등), 등급, 육종양 변화, 괴사, 절제면을 봅니다. 병리 결과가 **양성(암 아님)**으로 나오는 경우도 있습니다.

병기

쉬운 뜻

1기 7cm 이하, 신장에 국한

2기 7cm 초과, 신장에 국한

3기 신장 주위 지방·신정맥·대정맥 침범(T3a·T3b·T3c) 또는 림프절 전이

4기 신장을 싸는 막(제로타 근막)을 넘거나 같은 쪽 부신을 직접 침범(T4), 또는 원격전이

- 절제면에 암세포가 닿아 있다고 나와도 **곧바로 재수술을 뜻하지는 않습니다.** 추적 계획을 확인하세요.
- 흉부 CT의 작은 폐 결절·"불확정" 병변은 전이를 뜻하지 않을 수 있습니다. 추적 영상으로 확인합니다.
- 과거 결과지의 "유두상 1형/2형" 표기는 최신 분류에서 쓰지 않는 경향입니다 (확인 필요).

 **완전판에서 이어집니다** — 판독지 용어 사전, 추적 영상 기록표

PART 2. 치료 결정 — 2~3주차

5장. 작은 신종양: 감시·소작·부분절제

30초 요약: 크기·성장 속도·나이·신장 기능·동반질환·**불안 정도**를 함께 봅니다. 감시를 선택해도 불안은 자연스럽고, 불안이 너무 크면 그것도 치료 선택에 반영할 수 있는 정당한 요소입니다.

선택지	내용	생각할 점
적극적 감시	정기 영상으로 크기 변화 관찰	고령·동반질환·작은 종양에서 흔함
국소소작(고주파·냉동)	바늘로 종양을 태우거나 얼림	대개 3cm 안팎 이하, 시술 전·중 조직검사를 함께 하기도
부분신절제	종양만 떼고 신장 보존	신장 기능 보존에 유리, 위치에 따라 난이도 다름

- 감시는 보통 3~6개월마다 영상검사로 시작합니다. 치료로 바꾸는 흔한 기준 예: **1년에 약 5mm 이상 자람, 4cm를 넘음, 증상 발생**(담당 의료진 확인).

 **완전판에서 이어집니다** — 작은 신종양 의사결정 워크시트

6장. 수술: 부분 vs 근치적 신절제

30초 요약: 가능하면 신장을 지키는 **부분신절제**를 우선 고려하고, 종양이 크거나 위치상 어려우면 **근치적 신절제**를 합니다. 복강경·로봇·개복은 종양에 맞춰 정합니다. 국내에서는 로봇 부분신절제술에 비급여 항목이 많아 본인 부담이 클 수 있습니다. 급여 범위가 넓어지는 중이니 예상 비용을 원무과에 확인하세요(확인 필요).

■ **완전판에서 이어집니다** — 수술 후 회복 일정과 신장 지키는 생활

7장. 수술 후 보조 면역치료

30초 요약: 재발 위험이 중간·고위험·고위험인 투명세포 신장암(전이 병소를 완전히 절제한 일부 포함)은 수술 후 **면역치료 약 1년**(대표 예: 펌브롤리주맵)이 범주로 권고되며, 재발 감소와 **생존 연장이 보고되었습니다**(국내 허가·급여 확인 필요). 보조 표적치료(먹는 약)는 일반적으로 우선 권고되지 않습니다.

- 보통 수술 후 회복을 거쳐 약 12주 이내에 시작하는 경우가 많으니(담당의 확인), 수술 후 회복과 함께 **종양내과 상담 일정**을 미리 잡으세요.
- 갑상선·부신 등 **내분비 부작용 일부는 회복되지 않아 호르몬약을 계속 먹어야 할 수 있습니다.**
- 면역치료 카드를 지갑에 넣고 응급실·다른 과 진료 때 보여 주세요.

■ **완전판에서 이어집니다** — 보조 면역치료 결정표

8장. 전이성 신장암

30초 요약

- IMDC 위험군(양호/중간/불량)과 조직형으로 치료를 정합니다.
- 투명세포형 1차는 **면역 + 면역**(대표 예: 니볼루맙 + 이필리무맙) 또는 **면역 + 표적(먹는 혈관신생억제제)**(대표 예: 펌브롤리주맙 + 악시티닙) 병용 범주가 중심입니다(국내 허가·급여 확인 필요). 국내에서는 면역+면역 병용이 IMDC 중간·불량 위험군에서 건강보험 급여 대상입니다(2026.10 기준, 확인 필요). 양호 위험군이라면 급여되는 조합이 무엇인지 함께 물어보세요.
- 전이가 적고 천천히 자라는 일부는 **일정 기간 관찰 후 치료 시작**을 논의할 수 있습니다.
- 1차 이후에는 다른 표적치료, **HIF-2 α 억제제** 등 후속 범주가 있습니다.
- 1차 이후에는 다른 표적치료(면역치료 뒤에는 카보잔티닙·엑시티닙 등을 흔히 씀), **HIF-2 α 억제제** 등 후속 범주가 있습니다. HIF-2 α 억제제는 국내에서 아직 쓰기 어려울 수 있어 사용 가능 여부와 임상시험을 함께 물어보세요(확인 필요).
- 선택된 경우 신절제·전이 절제·방사선(SBRT)을 함께 씁니다.

진행·전이로 진단받았다면

30초 요약

- 전이가 있어도 치료 선택지는 있습니다. 치료 목표가 **암을 조절하며 오래, 덜 아프게 사는 것**으로 바뀌는 경우가 많습니다.
- **완화(지지)의료는 마지막 단계의 돌봄이 아닙니다.** 진단 시점부터 항암치료와 함께 통증·피로·숨참·불안을 줄이는 치료입니다.
- 첫 진료에서 "제 치료 목표는 무엇인가요?"를 꼭 물어보세요.

■ 완전판에서 이어집니다

- 치료 목표 대화법, 완화의료·호스피스 이용법, 사전연명의료의향서, 치료를 쉬는 선택
- 2차 소견 받는 법, 병원 선택 기준, 다학제 진료, 임상시험 찾는 법

PART 3. 30일 실행 로드맵

■ **완전판에서 이어집니다** — 30일 실행 로드맵(일자별 체크리스트)

PART 4. 치료 중·후의 몸과 마음

전신치료 중 자기 관리

30초 요약: 먹는 표적치료제는 **혈압 상승·설사·손발 피부 반응·피로·갑상선 기능 저하**가 흔합니다. 집에서 혈압과 체중을 기록하세요.

■ **완전판에서 이어집니다** — 먹는 표적치료제 증상별 '집에서·전화' 표, 혼자 사는 환자의 지원 서비스

추적

- 수술 후 첫 영상은 보통 수개월 안에 찍습니다. 국내 자료에서는 대개 2년까지 3~4개월마다, 그 뒤 6개월~1년마다, 5년이 지나면 1~2년마다 검사하는 일정을 예로 듭니다(병기에 따라 다름). 드물게 아주 늦게 재발하기도 해 5년 뒤에도 추적이 이어질 수 있습니다.
- 신장 기능(크레아티닌)과 혈압을 함께 추적합니다.

■ **완전판에서 이어집니다** — 치료 중 증상별 자가관리 표(메스꺼움·피로·입안 혈음·변비·설사·불면·탈모·피부·손발 저림)

마음 돌보기

30초 요약

- 진단 후 불안, 잠 못 들, 멍함, 화, 눈물은 **흔하고 자연스러운 반응**입니다. 약해서가 아닙니다.
- 2주 넘게 일상이 무너지거나, 스스로를 해치고 싶은 생각이 들면 **혼자 견디지 말고** 바로 도움을 요청하세요.
- 자살·정신건강 위기 상담 ☎ **109**(24시간), 응급 ☎ **119**
- 지금 마음의 고통은 0~10 중 ____ 점. 4점 이상이면 다음 진료에서 그대로 말하세요.

■ 완전판에서 이어집니다

- 고통 온도계, 불안을 다루는 5분 방법, 상담 연결 경로, '내 탓' 생각 다루기
- 보호자 역할 나누기, 아이에게 알리는 법, 보호자 휴가 제도, 보호자 자신의 돌봄
- 직장 병행 전략, 회사에 말하는 범위, 복귀 계획
- 치료 중 식사·운동 원칙과 피해야 할 것

PART 5. 돈 · 서류 · 제도

한국에서 꼭 챙길 제도와 서류

30초 요약

1. **산정특례 등록**: 암 확진 후 **30일 이내**에 신청하면 확진일부터 건강보험 본인부담이 크게 줄어듭니다(급여 항목 기준 5%). 진단받은 병원 원무과에 "산정특례 신청"을 오늘 물어보세요.
2. **서류는 처음부터 두 부씩**: 병리보고서, 영상 판독지, 진단서는 보험·회사·2차 소견에 반복해서 쓰입니다.
3. **제도는 바뀔니다**: 금액·기준은 2026년 10월 기준이며, 공단(1577-1000)·원무과에서 다시 확인합니다.

■ **완전판에서 이어집니다** — 산정특례 신청 절차, 의료비 지원제도, 실손·암보험 서류, 회사 서류 체크리스트

PART 6. 진료실 도구

진료실 질문 모음 — 한 번에 3개씩

진단 직후에는 1~3번, 치료를 정할 때는 4~7번, 치료 시작 전후에는 8~10번 중 **3개만** 골라 가세요. 보호자가 답을 적으면 충분합니다. 1. 종양의 크기·위치, 고형/낭성은요? 2. 감시·소작·부분절제·전절제 중 무엇이 가능한가요? 3. 조직검사가 필요한가요? 4. 수술 후 신장 기능은 어떻게 될까요? 5. 조직형과 등급은요? 6. 보조 면역치료 대상인가요? 기대 이득은요? 7. 전이성이라면 IMDC 위험군과 1차 치료는요? 8. 유전상담이 필요한가요? 9. 바로 연락해야 할 증상은요? 10. 임상시험이 있나요?

내 신장암 한 장 요약

항목	내 기록
크기·위치	_ cm , _
고형/낭성(Bosniak)	_____
조직형·등급	_____
병기	_____
신장 기능	수술 전 _ / 후 _
첫 치료	감시 / 소작 / 부분절제 / 전절제 / 전신치료
보조치료	해당 없음 / 상담 / 시작
IMDC(전이성)	양호 / 중간 / 불량

오늘 꼭 물을 3가지: ① 감시가 가능한가요? ② 신장을 지킬 수 있나요? ③ 보조치료가 필요한가요?

■ 완전판에서 이어집니다

- 같은 진단을 받은 세 사람의 30일(가상 사례)
- 신장암 용어사전
- 신장암 자주 묻는 질문 12
- 진료실 대화법(15분 진료를 30분처럼), 검사 준비 카드(CT·MRI·PET·조직검사·내시경)
- 워크북: 진료 기록지, 7일 증상 일지, 약·보충제 목록, 연락처 카드, 30일 체크달력

근거와 한계

- **참고 지침:** NCCN Clinical Practice Guidelines in Oncology (NCCN Guidelines®) — Kidney Cancer, Version 1.2027. NCCN의 표·알고리즘·문장을 옮기지 않고, 환자 언어로 새로 썼습니다.
- **국내 자료:** 국가암지식정보센터(www.cancer.go.kr) 신장암 정보, 대한비뇨의학회·대한비뇨기종양학회 자료, 국민건강보험공단 산정특례 안내
- **국가암지식정보센터 자료의 이용 방식:** 이 책은 국가암지식정보센터(구 국가암정보센터)의 글·표·그림을 옮기거나 고쳐 쓰지 않았습니다. 같은 사실을 대조·확인하는 데 참고했고, 문장은 ApuDa가 새로 썼습니다(센터 저작권 안내의 이용조건: 비영리·저작권 표시·내용 변경 금지·영리 이용 시 사전 협의를 따릅니다).
- **출처:** 보건복지부·국립암센터 국가암지식정보센터 — 사실 확인에 참고한 자료(센터 문장·그림은 쓰지 않음). 더 자세한 암 정보와 상담은 www.cancer.go.kr, ☎ 1577-8899(평일 9~18시).
- **의학정보 확인일:** 2026.10.04. 약의 국내 허가·급여, 면역치료·표적치료 적용 기준, 제도 금액은 바뀔 수 있습니다.

- **감수:** ApuDa 「첫 30일」 감수단(전문의 30인·환자 36인·편집자문 3인 역할 기반 **AI 사전 검토단**)의 1·2차 검토를 반영했습니다. 이 검토는 실제 면허 의료진의 최종 감수를 대신하지 않습니다. 출판본에는 실제 감수자 명단이 별도 표기됩니다.
- 이 책은 NCCN이 검토·승인한 자료가 아니며, NCCN과 무관한 ApuDa의 독자적 환자교육 저작물입니다.
- 이 자료는 일반적인 환자교육용이며 개인의 진단·처방·치료 결정을 대신하지 않습니다.

완전판에는 이런 내용이 더 있습니다

- 판독지 용어 사전, 추적 영상 기록표
- 작은 신종양 의사결정 워크시트
- 수술 후 회복 일정과 신장 지키는 생활
- 보조 면역치료 결정표
- 치료 목표 대화법, 완화의료·호스피스 이용법, 사전연명의료의향서, 치료를 쉬는 선택
- 2차 소견 받는 법, 병원 선택 기준, 다학제 진료, 임상시험 찾는 법
- 30일 실행 로드맵(일자별 체크리스트)
- 먹는 표적치료제 증상별 '집에서/전화' 표, 혼자 사는 환자의 지원 서비스
- 치료 중 증상별 자가관리 표(메스꺼움·피로·입안 혈음·변비·설사·불면·탈모·피부·손발 저림)
- 고통 온도계, 불안을 다루는 5분 방법, 상담 연결 경로, '내 탓' 생각 다루기
- 보호자 역할 나누기, 아이에게 알리는 법, 보호자 휴가 제도, 보호자 자신의 돌봄
- 직장 병행 전략, 회사에 말하는 범위, 복귀 계획
- 치료 중 식사·운동 원칙과 피해야 할 것
- 산정특례 신청 절차, 의료비 지원제도, 실손·암보험 서류, 회사 서류 체크리스트
- 같은 진단을 받은 세 사람의 30일(가상 사례)

- 신장암 용어사전
 - 신장암 자주 묻는 질문 12
 - 진료실 대화법(15분 진료를 30분처럼), 검사 준비 카드(CT·MRI·PET·조직검사·내시경)
 - 워크북: 진료 기록지, 7일 증상 일지, 약·보충제 목록, 연락처 카드, 30일 체크달력
-

ApuDa.app — 더 많은 암·질환 교육 콘텐츠와 업데이트 Instagram 구독자 무료 배포판 · 상업적 재배포 금지

ApuDa | 아프지만, 다행이다. · <https://apuda.app/>